

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Andrea Catalina Gutiérrez Soto

DOCUMENTO

CC 52999123

FECHA NACIMIENTO

03/05/1990

EDAD

36 años, 8 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Universitaria

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

13/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

post_tratamiento_adulto

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Andrea Catalina Gutiérrez Soto	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 52999123	Ocupación:	Administradora de empresas
Fecha de nacimiento:	03/05/1990	Ciudad:	Manizales
Edad:	36 años, 8 meses	Acompañante:	Pareja Juan Pablo Ortiz
Sexo:	Femenino	Remite:	Consulta particular (continuidad)
Escolaridad:	Universitaria	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Cierre de proceso terapéutico. Ingreso en 2025-11-10 con F41.1 (TAG) severo. Completó 12 sesiones de TCC + técnicas de mindfulness. Pre/Post comparación favorable.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: post_tratamiento_adulto

Prueba	Dominio	Dur.
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
COMPRENSIÓN	Comprensión Verbal	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención sostenida normalizada. Reporta capacidad de concentrarse en tareas laborales durante 1 hora sin fatiga (línea base: 20 min).

Memoria

Memoria funcional subjetiva . Olvidos cotidianos en rango normal. Sin quejas.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje fluido, sin pausas ansiosas. Voz proyectada. Mejor uso de pausas.

Funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas conservadas. TMT-A y TMT-B dentro de percentiles esperados. Mejora significativa en planificación y resolución de problemas.

Emociones y comportamiento

Eutimia. BDI-II 6 (inicial 22 — cambio confiable RCI = -16, $p<0.05$). Atribuye mejoría a: técnicas cognitivas, exposición gradual, mindfulness, regularización sueño-ejercicio.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada + cierre terapéutico exitoso

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo



Perfil Z por prueba

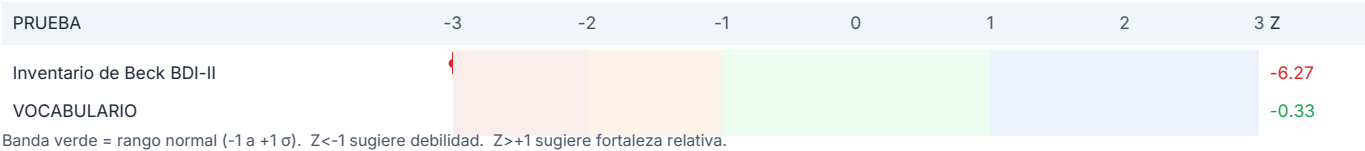


Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Inventario de Beck BDI-II	6	6	-6.27	Mínima
VOCABULARIO	36	9	-0.33	Promedio
COMPRENSIÓN	35	—	—	Sin dato

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil cognitivo se ubica globalmente dentro del rango normal esperado para la edad, sin debilidades ni fortalezas significativas en los dominios evaluados.

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Andrea. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

Fortalezas (lo que se hace bien)

- En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: MANTENIMIENTO: continuar con práctica diaria de mindfulness (10 min) y registro semanal de pensamientos automáticos (1 vez/sem). (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: SEÑALES DE ALERTA para reconsulta: reaparición de preocupaciones incontrolables >2 semanas, deterioro del sueño, evitación social creciente. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Pareja informada sobre el plan de mantenimiento. Apoya la práctica de autocuidado. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Reevaluación de seguimiento opcional en 6 meses (2026-12). Cierre formal del caso si se mantiene la mejoría. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F41

Impresión diagnóstica: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada + cierre terapéutico exitoso

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Pareja informada sobre el plan de mantenimiento. Apoya la práctica de autocuidado.
- Reevaluación de seguimiento opcional en 6 meses (2026-12). Cierre formal del caso si se mantiene la mejoría.

General

- [LABORAL] Mantener estrategias de manejo de estrés laboral (pausas activas, desconexión digital post-19:00).